

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРАКТИКОВ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Связное руководство, которое читается подряд и к которому возвращаются за ответом. Проверяемые источники, честные оговорки о границах данных, разбор ситуаций.

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“»

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Методическое руководство для руководителей и практиков стационарных организаций социального обслуживания. Автор: Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“».

Предисловие

Представьте обычный обед в доме на триста человек. В зале — очередь: тех, кто ест самостоятельно, кормят первыми, потому что так быстрее; тех, кому нужна помощь, — последними, и еда доходит до них холодной. У одного жителя вторую неделю стоит почти нетронутая тарелка, но журнала, куда это записывают, нет, и лечащий врач узнаёт об отказе случайно, на плановом обходе в четверг. Другому родственники принесли термос крепкого кофе — а он принимает клозапин, и кофеин здесь не безобидная привычка, а вещество, заметно меняющее концентрацию лекарства в крови. Третий просит добавки, и помощник по уходу отказывает: «вам нельзя, вы и так полнеете», — хотя никакого врачебного назначения на этот счёт не существует. А на следующей неделе проверка, и суточные пробы за минувшие двое суток подпишут сегодня, задним числом.

Пять сцен — и в каждой на поверхности свой виновный: медлительный помощник, капризный житель, невнимательная семья, несдержанный сосед, нерадивый завхоз. Но если приглядеться, виновных нет. Есть система организации питания, которая в пяти разных точках не сработала. И существенно, что ни одна из этих точек не про «дать два блюда на выбор»: они про то, доходит ли до тарелки обычная, предусмотренная законом забота.

С этого наблюдения имеет смысл начинать разговор о вариативном питании, потому что вокруг него сложилось два одинаково бесполезных мифа. Первый: «выбор блюда — это про удовольствие, а нам бы накормить». Второй: «дайте денег, и мы устроим ресторан». Оба мифа уводят от сути. Организация питания в доме социального обслуживания — это не кухонный вопрос и не вопрос щедрости бюджета. Это управляемая система, в которой безопасность имеет приоритет, медицинскую рамку задаёт врач, внутри допустимой рамки человеку предоставляется понятный выбор, выбор документируется, а результат измеряется. Право жителя на достойное питание либо доходит до его тарелки, либо остаётся строкой в законе — и превратить второе в первое можно без второй кухни и без новой сметы, но нельзя без порядка.

Что это за руководство. Перед вами не стенограмма выступления и не научная монография, а методическое руководство: связный текст, который можно прочитать подряд за несколько вечеров и к которому можно вернуться через полгода за конкретным ответом. Оно опирается на проверяемые источники — российское право, клинические исследования, зарубежные нормы — и всюду, где доказательная база тонка или отсутствует, говорит об этом прямо, а не выдаёт правдоподобное за установленное. Там, где утверждение может стать предметом спора с проверяющим, указан его статус: норма закона, толкование нормы, рекомендация практики или проект локальной формы. Это разграничение — не педантизм, а техника безопасности: директор, различающий норму и рекомендацию, не попадёт впросак ни перед прокурором, ни перед учредителем.

Как оно построено. Двенадцать глав идут от простого к сложному и от общего к операционному: от вопроса «кто вообще решает, что на тарелке» — через клинические границы, право, технологию, деньги — к пилоту на девяносто дней и первым действиям понедельника. Клинические и правовые сюжеты иллюстрируются короткими разборами ситуаций; все они собирательные, составлены для анализа и не описывают конкретных людей. Рабочий инструментарий — шаблоны положений, журналов, форм — вынесен в отдельное приложение-практикум, чтобы не разрывать чтение; в тексте на него даются ссылки.

Одно предупреждение и одно обещание. Предупреждение: эта книга не заменяет ни врача, ни юриста, ни финансиста вашего учреждения — она помогает задать им правильные вопросы. Обещание: ни одна цифра здесь не приведена «для красоты». За каждой стоит источник и, где нужно, оговорка о границах её применимости. Последнее слово руководства — не «внедряйте», а «измеряйте»: семь дней честного замера отделяют убеждение от знания.

Глава 1. Кто решает, что на тарелке

1.1. ПРОСТОЙ ВОПРОС, ОБНАЖАЮЩИЙ СИСТЕМУ

Начнём с вопроса, который стоит задать себе и своей команде до всякой методики: **кто в вашем доме решает, что сегодня лежит на тарелке конкретного жителя?** Он сам? Помощник по уходу? Лечащий врач? Заведующий производством? Поставщик, выигравший контракт? Региональная норма питания, которую, честно говоря, мало кто держал в руках?

Задавая этот вопрос в разных залах, я слышу два устойчивых ответа. Первый, самый частый: «кухня». Второй: «норма». Ответ «он сам» звучит реже всего. В этом нет ничьей злой воли — так сложилась система, в которой еда выдаётся, а не выбирается. Но именно здесь скрыт корень темы. Еда — самое частое событие в жизни жителя: три, четыре, а при шестиразовом режиме и шесть раз в день, каждый день, годами. Ничего другого мы не повторяем с человеком так часто. И если в этом самом частом событии за него всё и всегда решают другие, то разговор о правах жителя, каким бы правильным он ни был на бумаге, до его тарелки не доходит.

1.2. ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЧИТ «НАКОРМИТЬ»

Слово «накормить» кажется простым и однозначным, и в этой мнимой простоте — источник большинства ошибок. На деле за ним скрываются как минимум шесть разных задач, и решать их приходится одновременно. Полезно назвать их по именам, потому что провал обычно случается не там, где мы смотрим.

Первое — достаточность. Человек должен получить положенные калории, белок и микронутриенты. Это измеримо и нормировано, и именно сюда направлено внимание проверок. Но достаточность рациона на бумаге ещё не означает, что еда съедена: полная тарелка, вернувшаяся нетронутой, — это формально выполненная норма и фактическое недоедание.

Второе — безопасность. У нашего контингента она не сводится к свежести продуктов. Это ещё и правильная текстура пищи для того, кто рискует поперхнуться; это учёт того, как еда и напитки взаимодействуют с психотропными препаратами; это защита от заглатывания несъедобного. Безопасность — единственное измерение, где право на выбор ограничивается, и ограничивает его не кухня, а врач.

Третье — приемлемость, то есть попросту вкус и привычность. Измерение, которое чаще всего называют «баловством», — и которое даёт самый массовый повод для жалоб. Невкусно и однообразно — это не каприз, это несъеденные калории и растущее раздражение зала.

Четвёртое — социальность. Совместная трапеза — форма человеческого общения, а не только приём пищи. Организация зала, темп раздачи, присутствие персонала за столом влияют на то, сколько человек съест, не меньше, чем состав меню.

Пятое — самостоятельность. Возможность есть самому — навык, который легко потерять и трудно вернуть. Помощник, который из лучших побуждений кормит того, кто ещё может есть сам, экономит десять минут сегодня и отнимает умение навсегда.

Шестое — выбор. Возможность повлиять на то, что окажется на твоей тарелке. Это и есть вариативность, вокруг которой идут споры. Важно сразу поставить её на место: выбор — шестое измерение, а не первое. Дом, где не закрыты первые пять, вариативностью проблему не решит — только добавит шестую точку отказа.

Эти шесть измерений — не абстракция, а рабочая рамка. Почти любую претензию к питанию — жалобу жителя, замечание проверяющего, тревогу врача — можно точно отнести к одному из шести и потому осмысленно на неё ответить. Дальнейшие главы, по сути, разбирают эти измерения по очереди: клиника (главы 3–4) — про безопасность; право (глава 5) — про границы выбора; технология и деньги (главы 7 и 10) — про то, как обеспечить приемлемость и выбор, не жертвуя достаточностью и не требуя новой кухни.

1.3. ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС РУКОВОДСТВА

Если свести всё изложенное к одному предложению, оно звучит так. **Вариативное питание в доме социального обслуживания законно, клинически безопасно при соблюдении границы «врач решает — кухня исполняет» и осуществимо на обычной кухне без второй производственной линии — при одном условии: если внедрять его как документированную систему с пилотом и замером «до и после», а не как лозунг.** Всё остальное в этой книге — обоснование и операционализация этого тезиса: откуда берётся «законно», где проходит граница «безопасно», что именно значит «документированная система» и как устроен замер, отличающий работающую практику от её имитации.

Мы не станем утверждать, будто вариативность непременно улучшает здоровье или снижает отходы: убедительных исследований такого эффекта в психиатрической популяции пока нет, и об этом честно сказано в главе 9. Мы утверждаем более скромное и более полезное: выбор можно организовать безопасно и за понятную цену, а доходит ли он до тарелки — можно проследить и измерить. С этого и начинается управление вместо благих намерений.

Источники к главе. Оценка доли недееспособных проживающих и общего устройства сети интернатов — по данным за 2024 год, обработанным аналитическим проектом «Если быть точным» (публикация 2026; это вторичная аналитика, не официальная статистика Минтруда, и в конкретном учреждении доля отличается). Клинические сюжеты, упомянутые вскользь (взаимодействие клозапина и кофеина, метаболический эффект антипсихотиков, риск дисфагии), подробно разобраны с указанием первоисточников в главах 3 и 4.